



Unité d'enseignement intégrée 01 **Psychologie Médicale**

Problèmes particuliers de l'entrevue Médicale

Pr Ag. Bouzid
Médecine Interne

Oran le 24/09/2025

Objectifs

- Connaitre les bases d'une entrevue ou d'un interrogatoire réussi.
- Déterminer les problèmes de l'entrevue en rapport avec le comportement du médecin.
- Déterminer les problèmes de l'entrevue en rapport avec le comportement du malade et son entourage.

Introduction

L'art de la médecine repose sur la capacité du médecin à mener une entrevue réussie, un interrogatoire à la fois concis et complet et à examiner le patient avec efficacité et compétence.

Les renseignements recueillis au cours de l'entrevue servent à :

- Définir le motif de consultation.
- Définir l'hypothèse diagnostic.
- Guider l'examen physique,
- Diriger le type d'examens complémentaires à demander.

Organisation de l'entrevue

- **La collecte des information** du patient à travers de questions pertinentes :
 - Recueillir des renseignements valides et sans ambiguïté.
 - Recueillir des renseignements additionnels en cas problème clinique complexe et de morbidités multiples (Diabète , hypertension, cardiopathies....).
 - Avoir si nécessaire d'autres sources telles que la famille du patient, le personnel soignant ou d'autres professionnels.

- Cela exige au médecin de remplir **les conditions** suivantes :
 - Offrir les conditions appropriées à l'entrevue.
 - Offrir le sentiment de bienvenu et mettre le malade à l'aise.
 - Savoir écouter , Etre ouvert et flexible.
 - Interpréter correctement les données.
 - Gagner sa confiance et un terrain d'entente.
 - Réagir de façon appropriée à la situation.
 - Former un récit cohérent de l'histoire de la maladie.



Empathie

Le médecin devra apprendre à être empathique à l'égard du patient :

- Être sincère.
- Montrez une attention clairement accordée.
- Se mettre à la place du patient.
- Appréhender le problème du point de vue du patient.
- Traiter les problèmes avec Respect.
- Montrez votre soutien.
- Avoir la volonté de coopérer avec le patient (Esprit de partenariat).



- Empathie cognitive :
Comprendre les idées du patient.
- Empathie émotionnelle :
partager ses sentiments.

Interrogatoire

Pour un **interrogatoire de qualité**, il faudra respecter les conditions suivantes :

- Le médecin devra avoir une allure professionnelle, ordonné avec une tenue adaptée.
- Maintenez un contact visuel rassurant et une attitude ouverte.
- Prendre en compte le langage non verbal.
- Interrogatoire avec respect, patience, à l'aide d'un discours simple compris par le patient.
- Questions avec ton accueillant sans influencer la réponse du patient.
- Le médecin doit savoir écouter, laisser parler, relancer, revenir sur certains points pour les préciser, en gardant l'esprit ouvert et faire preuve de flexibilité.
- Encourager le patient à s'exprimer.
- Clarifiez avec le patient la liste des plaintes principales.
- Posez davantage de questions pour vérifier les faits, afin de construire une histoire cohérente.



Un bon interrogatoire ne laisse **pas de place à l'interprétation**, il ne recherche que des faits.

Sir William Osler (1849–1919)

« Lors de l'interrogatoire :

- coutez tout ce que le patient a à dire
- Ne posez pas de question dirigée,
- Ne faites jamais de suggestions,
- Laissez le patient s'exprimer avec ses propres mots ».



Communication

De bonnes compétences de communication sont un élément central de la bonne pratique clinique. Il faut maîtriser différents scénarios de communication, notamment :

- Parler au patient et son entourage.
- Interroger un malade avec affection psychiatrique.
- Interagir avec un patient aveugle ou sourd.
- Comment gérer une entrevue dans le cadre de l'urgence (Le médecin devra être calme et rassurant).
- Savoir comment poser des questions personnelles.
- Comment s'adresser à un patient ou à un proche mécontent des soins médicaux prodigués.
- Comment discuter avec un patient atteint d'une maladie grave ou annoncer de mauvaises nouvelles.



Style de questionnement

- **Début de l'entrevue : question ouverte .**
« Alors, qu'est-ce-que je peux faire pour vous ? »
« C'est quoi la raison de votre visite? ».
- **Par la suite des questions fermées : Réponse absolue.**
« Vous avez quel âge ? »
« Est-ce que vous êtes mariée? »
- **Le long de l'entrevue :**
 - Renseignements concernant des symptômes cliniques.
 - Série de questions liées à chaque symptôme ou maladie.
 - Terminez par des questions spécifiques pour restreindre les diagnostics différentiels.



Problèmes de la langue

Le problème de la maîtrise de la langue peut se poser lors d'une entrevue médicale :

- Langue maternelle est différente (langue étrangère, kabyle....).
- Faire appel à un interprète médical officiel (interrogatoire plus long et plus difficile).
- Les questions doivent être formulées comme si elles étaient directement adressées au patient.
- Etablir un contact visuel avec le patient plutôt qu'avec l'interprète, pour que le patient ne se sente pas exclu de la discussion.
- Éviter de faire appel à un proche du patient comme interprète pour réduire le risque de biais. •



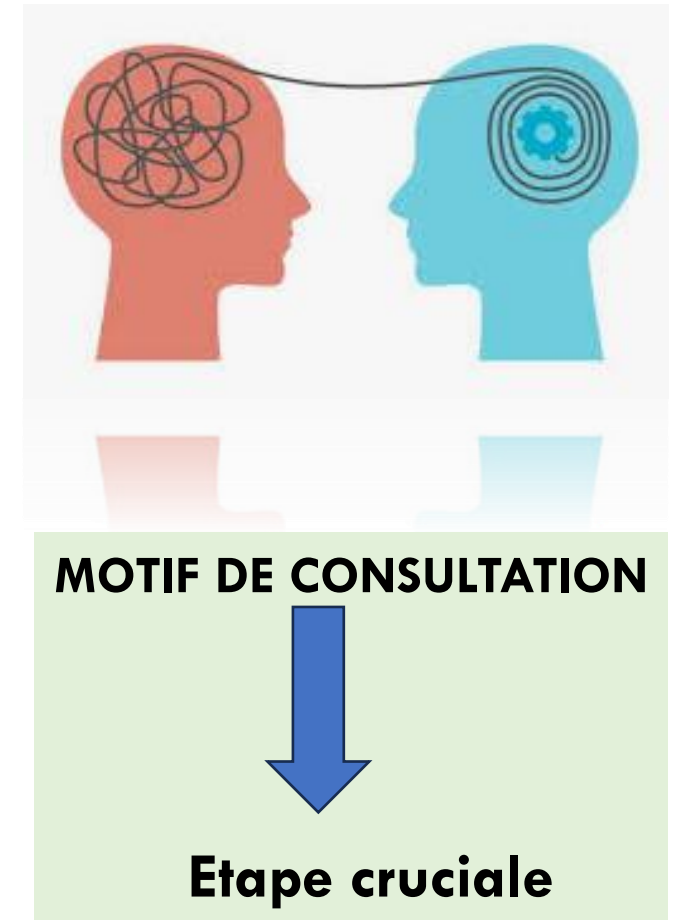
Motif de consultation

L'entrevue a comme objectif d' établir quel est le motif de consultation :

- Déterminer ce qui gêne le patient.
- Ce que le patient souhaite que le médecin solutionne .
- C'est donc une plainte, un symptôme, jamais un diagnostic.

EXP : Le patient « consulte pour un motif de **toux** et de la **fièvre** ».

C'est au terme de la démarche médicale que l'on conclura à une **pneumopathie** qui représente le diagnostic.



Attitudes du patient

Le patient peut être coopérant , mais aussi pourra avoir des attitudes rendant le contact difficile :

- Réticent ou incapable de parler nécessitant une mise en confiance.
- Brouiller les cartes consciemment ou inconsciemment.
- Oublier un épisode du passé.
- Peu coopératif / trop coopératif (vérifier la validité des renseignements recueillis).
- Interpréter les choses de manière erronée.
- Être déprimé, anxieux, effrayé, en colère, ou agressif :
➡ en parler avec tact.
- Réaction émotionnelle : nécessite des compétences de gestion des émotions, compréhension, soutien.



EXP: Attitudes en rapport avec raison médicale :

- Sevrage d'alcool ou de drogues,
- Lésion intracrânienne (tumeur ou un hématome).
- Maladie psychiatrique,
- Infection chez le sujet âgé.

Attitudes du médecin

Le médecin au cours de l'entrevue devra respecter les points suivants :

- Écouter activement et cerner la personnalité du patient.
- Prendre tous les problèmes du patient au sérieux.
- Inviter les proches du patient à assister à la consultation, mais seulement si le patient le souhaite (pas trop de monde dans la pièce).
- Être poli et ne juger pas votre patient.
- Adopter une attitude éthique : preuve de respect de l'intimité, la culture et la religion du patient.
- Rencontre strictement professionnelle et ne revêt aucun intérêt personnel inapproprié.
- Détachement du médecin de son patient afin d'éviter toute manipulation consciente ou inconsciente.



Attitude des Proches du patients

L'Idéal que l'entrevue soit directe avec le patient. Il faudra faire en sorte que le patient se trouve entre vous et son proche. L'attitude de l'entourage pourra être problématique par son intervention (Entrevue moins directe) :

- Interruption voir contradiction de la version du malade et des faits.
 - Symptômes du patient susceptibles d'être « filtrés » ou interprétés avant que l'information n'arrive au clinicien.
-
- Avec tact, faire comprendre au proche qu'il doit laisser le patient répondre avec ses propres mots.
 - Un patient atteint de démence ou mineur , ou ne pouvant s'exprimer peut avoir besoin d'aide pour fournir des renseignements exacts.



Situations particulières

Il est important de gérer l'entrevue médicale dans les **situations particulières** :

- Déterminer l'influence du contexte personnel et culturel du patient sur les choix qu'il fait (serrer la main ou se faire examiner par le sexe opposé).
- Situations particulières : sujet Age , état démentiel , urgences..., état de dépression ou anxiété importante avoir parfois la nécessité de l'intervention d'une tierce personne.
- Sujets « sensibles » : tel que la sexualité, alcool , toxicomanie, deuil , clandestinité...). Le médecin devra agir avec tact et respect, avec un discours explicite et sans jugement.
- Entrevue psychiatrique : Avoir du temps pour établir une relation de confiance avec le clinicien, et Savoir faire la part entre symptômes physiques et psychologiques.



Synthèse de l'entrevue

Le médecin devra lors de l'entrevue médicale arriver aux objectifs suivants :

- Cerner les renseignements importants.
- Clarification des données.
- Analyse objective des faits.
- Etablissement des liens entre les événements.
- Déterminer le problème du patient (le diagnostic le plus probable et les diagnostics différentiels).
- Diriger l'examen physique et les examens complémentaires.



Synthèse avec un résumé des faits



Raisonnement clinique
Conclusion valide
Diagnostic le plus probable.

Conclusion

- C'est au médecin de s'adapter au patient, et non l'inverse.
- Etablir une bonne relation avec le patient et gagner sa confiance et un terrain d'entente.
- Prendre en compte tous les problèmes pouvant entraver la réussite de l'entrevue médicale.
- La collecte et l'intégration des renseignements doivent être précises et complètes, afin de définir le motif de la consultation et la conduite à tenir.

Références

- Examen clinique et sémiologie : l'essentiel 2017 Elsevier Masson.
- Précis de sémiologie médicale, R M Hamladji.